

 INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO: FILIAL OMNISALUD

Documento Clasificado - Auditoría de Protección de Datos (Ley 21.719)

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Dashboard)

Este reporte detalla el hallazgo técnico resultante de la auditoría automatizada sobre el dataset de la filial **OmniSalud**, parte del Holding OmniGroup.

Métrica de Control	Estado	Observación Técnica
Nivel de Riesgo	● CRÍTICO	Exposición de datos de salud sensibles
Cumplimiento Ley 21.719	✗ NO CONFORME	Infracción al principio de finalidad
Estándar ISO 27701	⚠ BRECHA	Ausencia de controles de seudonimización

2. ANÁLISIS DE LA BRECHA TÉCNICA

Se realizó una inspección forense mediante scripts de Python sobre el repositorio de datos para verificar la segregación de la privacidad entre filiales.

2.1 Evidencia en Dataset: `omnisalud_clientes.csv`

El análisis detectó la presencia de datos de salud vinculados a la identidad del sujeto de forma directa, sin capas de abstracción.

HALLAZGO TÉCNICO: El campo **Patologia_Cronica** está expuesto en texto plano y vinculado al **ID_Interno**. Esta configuración permite la re-identificación inmediata del paciente fuera del ámbito clínico, facilitando la "contaminación cruzada" con la base de datos de la filial de seguros (OmniRetail).

2.2 Validación de Lógica de Auditoría

Se ejecutó un control técnico de validación para detectar el riesgo de infracción ante la futura **Agencia de Protección de Datos (APDP)**.

Lógica de detección aplicada:

- Si el origen de los datos es **OmniSalud** y existen campos de salud vinculados a IDs persistentes, se activa una alerta de riesgo gravísimo.
- La recomendación técnica inmediata es la implementación de **Tokenización Dinámica** para romper el vínculo identificador.

3. DICTAMEN JURÍDICO - ESTRATÉGICO

Bajo el nuevo marco regulatorio chileno, este hallazgo representa un riesgo financiero de hasta **20.000 UTM** por cada infracción detectada, sumado a una pérdida reputacional crítica para el Directorio del Holding.

Recomendaciones del DPO:

1. **Cifrado en Reposo:** Aplicar estándares AES-256 a la base de datos de patologías.
2. **Segregación de Funciones:** Implementar un modelo de acceso basado en roles (RBAC) que impida a las áreas comerciales acceder a registros médicos.
3. **Accountability:** Registrar esta brecha en el Libro de Incidentes y aplicar medidas de remediación antes de la plena entrada en vigencia de la Ley 21.719.

ANEXO TÉCNICO: EVIDENCIA DE SCRIPTING

Para la detección de la brecha se utilizó la siguiente lógica en Python:

```
import pandas as pd

# Carga de activos de salud
df = pd.read_csv('omnisalud_clientes.csv')

# Identificación de vinculación prohibida (Art. 9 Ley 21.719)
def auditoria_privacidad(data):
    for index, row in data.iterrows():
        if pd.notnull(row['Patologia_Cronica']) and pd.notnull(row['ID_Interno']):
            return "HALLAZGO: Contaminación de datos identificables detectada"

print(auditoria_privacidad(df))

**Gonzalo Vega Batyi** *Abogado Experto en Ciberseguridad y Protección de Datos*
*Certificado ISO 27001 / ISO 42001*
```